

2 漏斗胸

pectus excavatum

到達目標

- 漏斗胸の身体所見と症候を説明できる
- 漏斗胸の病態を説明できる
- 漏斗胸の画像所見と手術適応を説明できる
- 漏斗胸の治療法を説明できる

病 因

漏斗胸は前胸部が陥凹する疾患であり（図1），その発症率は400～1,000人に1人である。その病因として，家族内発生もみられることから，遺伝的素因があると考えられている。Marfan 症候群に漏斗胸が合併することはよく知られており，漏斗胸の主な病変部位である肋軟骨に何らかの結合組織の異常があるのではないかと推測されるが，遺伝子異常は明らかではない。小児期の扁桃腺肥大など上気道の閉塞がある場合は胸の陥凹が進行することがある。このことから，呼吸による胸郭の陰圧と肋軟骨の支持力が弱い場合に陥凹が生じるのではないかと推測される。漏斗胸は肋軟骨の過成長が原因といわれていたが，患者の肋軟骨長を計測した研究では過成長を示すエビデンスはなかった。

漏斗胸は幼児期から発症する場合と思春期の発症がある。思春期に発症する漏斗胸患者の特徴は身長が急激に伸びるときに胸の陥凹が進行する。成長が止まる

時期に陥凹の進行も止まる。漏斗胸が自然に軽快することはまれであり，成人になっても胸郭形態は変化しない。

症候・身体所見

漏斗胸では精神的な要因以外に症状はないことが多いが，特徴的な症候として，胸痛，労作時の息切れ，動悸，易疲労感を呈することがある。そのため，長距離走などのスポーツをすると苦しくなるという患者も多い。このような症状は年齢や胸の陥凹の程度により異なるが，思春期を過ぎる頃からみられるようになり，胸骨の陥凹により胸骨と椎体の間が狭い患者に多い。漏斗胸患者のCT画像（図2）をみると，心臓が前後に圧迫されており，心臓の拡張不全の状態を示す。そのため，1回拍出量が低下しているという報告もある¹⁾。外科手術後に心肺機能が改善することがみられることから，漏斗胸は単に外見の異常だけではなく，心肺機能の障害を持つ場合もある。

美容形成的問題による身体的コンプレックスで精神的な葛藤をかかえやすいことも特徴である。特に女性では胸郭変形に伴って乳房の変形が目立つため，美容上の大きな悩みとなる。一方，男性では上半身を露出する機会が多く，水泳や温泉などに行けない，身体的な劣等感から人前で自信を持って行動できないという問題も抱えている。

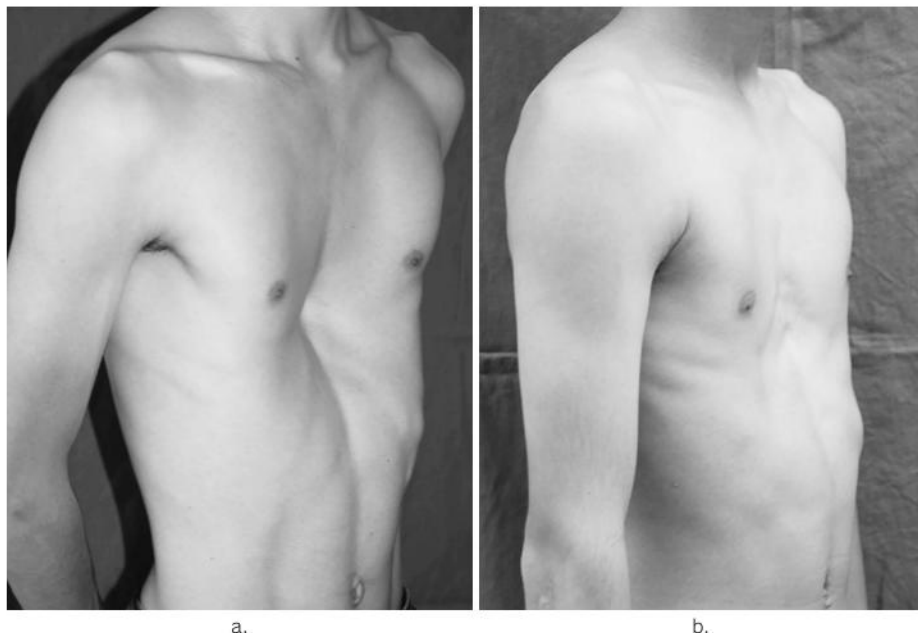


図1 漏斗胸の外観
a では前胸部の深い陥凹を認めるが，b では幅広く浅い陥凹を認める。